

Invaginação intestinal · dor intermitente

Lactente/pré-escolar com cólica intermitente, letargia e fezes em geleia de morango: pense invaginação. USG confirma; redução hidrostática/pneumática se estável.

Idade e causa

Lembre - Idade e causa

Pico 3–36 meses, muitas vezes ileocólica idiopática pós-viral. > instáveis / fora da faixa: pensar lead point (Meckel, pólipos, Púrpura de Henoch-Schönlein).

Fluxo: suspeita clínica !' imagem em alvo !' redução guiada ou cirurgia se peritonite/choque.

Invaginacao

Clinica -> USG -> reducao

Dor + letargia

fezes em geleia

USG alvo

target / doughnut

Enema / cirurgia

conforme estabilidade

Conduta

- Estabilizar, jejum, acesso, cirurgia ciente
- USG: sinal do alvo em corte transversal
- Redução por enema com ar/contraste se sem peritonite
- Cirurgia se falha, perfuração, choque ou massa/lead point

Clínica

Achado | Nota

Dor intermitente | Criança 'olha o vazio' entre crises

Vômitos | Podem tornar-se biliosos

Geleia de morango | Tardio; ausência não exclui

Massa em salsicha | QSD / epigástrio

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não atrase imagem esperando geleia de morango. Peritonite = centro cirúrgico, não enema terapêutico.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1